БОНУС 3

Описание според клиничния въпрос: 30 клинични въпроса

Какъвто и да е въпросът в направлението, първото изречение на Вашето описание трябва да отговори на него. За 30-те най-чести клинични въпроса: на какво задължително трябва да отговори описанието, отрицателно изречение и положително изречение.

Съдържание

Защо клиничният въпрос е на първо място

Невроренттенология — 5 въпроса

Гръден кош — 7 въпроса

Корем и таз — 10 въпроса

Съдова патология — 3 въпроса

Мускулно-скелетна система и гръбначен стълб — 5 въпроса

Следваща стъпка

НАЧАЛО

Защо клиничният въпрос е на първо място

В стъпка ПОДГОТВЕТЕ четете направлението; в стъпка ОБОБЩЕТЕ отговаряте на него.

> *Когато лекарят, издал направлението, отвори описанието, той търси само едно: отговора на своя въпрос. Ако не го намери, ще се обади по телефона или ще изтълкува описанието погрешно.*

1. **Прочетете направлението и сведете въпроса до една дума** — «апендицит?», «кръвоизлив?», «конкремент?».
2. **Въпреки това направете пълен преглед** — въпросът дава фокуса, но другите области не се пропускат.
3. **Покрийте в находките списъка «задължително» на въпроса** — всяка точка се записва или като положителна, или като значима отрицателна находка.
4. **Първото изречение на заключението е отговорът на въпроса** — при положителен резултат: находката и при нужда съобщаване; при отрицателен: ясно отрицателно изречение.
5. **Посочете ограниченията** — когато изследването не е достатъчно, за да изключи въпроса, посочете това изрично.

Ако направлението е неясно

При неясни направления като «контрол» или «болка» се опитайте да получите клиничната информация от документацията или от лекаря, издал направлението. Ако не успеете, структурирайте описанието според най-вероятния въпрос и отговорете поотделно за честите причини.

ЧАСТ 1

Невроренттенология

5 клинични въпроса

01 «Инсулт?»

Често използвано изследване: КТ на главен мозък без контраст ± КТ ангиография; ЯМР-DWI

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Има ли кръвоизлив или не (първо изречение)
- Ранни белези на исхемия и съдов басейн
- Белег на хиперденсна артерия
- Ако е направена КТ ангиография — оклузия на голям съд
- Час на съобщаване

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установява вътречерепен кръвоизлив. Не се визуализират ранни исхемични промени; ранният исхемичен инсулт може да не се вижда на КТ без контраст.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Няма вътречерепен кръвоизлив; [Вдясно/Вляво] ранни белези на остра исхемия в басейна на СМА. В рамките на инсултния протокол [час] — час на съобщаване.

02 «Черепно-мозъчна травма — кръвоизлив?»

Често използвано изследване: КТ на главен мозък без контраст (мозъчен и костен прозорец)

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Екстрааксиален и паренхимен кръвоизлив
- Обемен ефект и изместване на средната линия (mm)
- Базални цистерни
- Фрактура на калвариума и черепната основа
- Пневмоцефалия

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установява остър вътречерепен кръвоизлив, обемен ефект или фрактура на калвариума.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Вдясно/Вляво] остър [епидурален/субдурален] хематом; [.. mm] изместване на средната линия. [Час] — час на съобщаване.

03 «Внезапно силно главоболие — САК?»

Често използвано изследване: КТ на главен мозък без контраст ± КТ ангиография

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Субарахноиден кръвоизлив и разпределение
- Хидроцефалия
- Интравентрикуларен или паренхимен кръвоизлив
- Препоръка за КТА за оценка на аневризма

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установява субарахноиден кръвоизлив. Чувствителността на КТ намалява с времето от началото на симптомите; при персистиращо клинично съмнение по-нататъшната оценка е клинично решение.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[В базалните цистерни] субарахноиден кръвоизлив; хидроцефалия **[няма/има]**. Препоръчва се КТ ангиография. **[Час]** — час на съобщаване.

04 «Обемна формация?»

Често използвано изследване: ЯМР на главен мозък с контраст (при съмнение на КТ)

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Брой, локализация и размер на лезиите
- Разграничаване интра-/екстрааксиално
- Оток и обемен ефект
- Херниация
- Най-вероятна диференциална диагноза

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

На ЯМР на главен мозък с контраст не се установяват обемна лезия или патологично контрастно усилване.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Вдясно/Вляво] **[лоб]** **[.. mm]** **[интрааксиална/екстрааксиална]** обемна формация; **[диференциална диагноза]**. Белези на херниация **[няма/има]**.

05 «Хидроцефалия / дисфункция на шънта?»

Често използвано изследване: КТ на главен мозък без контраст; сравнение с предходното изследване

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Промяна в размера на вентрикулите спрямо предходното изследване
- Перивентрикуларен оток
- Позиция на върха на шънт катетъра
- Кръвоизлив

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Спрямо предходното изследване не се установява промяна в размерите на вентрикулите; върхът на шънт катетъра **[позиция]**.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Спрямо предходното изследване — изразено разширение на вентрикулите; може да е в полза на дисфункция на шънта. **[Час]** — час на съобщаване.

ЧАСТ 2

Гръден кош

7 клинични въпроса

06 «Пневмоторакс?»

Често използвано изследване: Рентгенография на гръден кош; при нужда КТ или POCUS

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Има ли пневмоторакс, страна
- Размер или количество
- Белези в полза на тензия
- Съпътстваща фрактура на ребро, подкожен емфизем

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установява пневмоторакс.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Вдясно/Вляво] пневмоторакс, в апекса [.. mm]; белези на тензия [няма/има]. [Час] — час на съобщаване.

07 «Пневмония?»

Често използвано изследване: Рентгенография на гръден кош; при нужда КТ на гръден кош

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Има ли консолидация, лоб/сегмент
- Плеврален излив
- Кавитация или абсцес
- Промяна спрямо предходното изследване

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

В белодробния паренхим не се установява консолидация в полза на пневмония.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Вдясно/Вляво] [лоб] консолидация; в съчетание с клиниката може да съответства на пневмония. Плеврален излив [няма/има].

08 «Белодробна емболия?»

Често използвано изследване: КТ белодробна ангиография

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Адекватност на контрастирането
- Има ли емболия и най-проксималното ниво
- Обременяване на дясната камера
- Алтернативна диагноза (пневмония, излив)

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Контрастирането на белодробната артерия е адекватно; не се установява белодробна тромбоемболия.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Двустранно] [лобарна/сегментна] остра белодробна тромбоемболия; обременяване на дясната камера [няма/има]. [Час] — час на съобщаване.

09 «Аортна дисекация?»

Често използвано изследване: КТ ангиография (без контраст + артериална фаза)

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Има ли дисекация
- Ангажиране на възходящата аорта
- Ангажиране на клоновете и органна перфузия
- Перикарден излив, медиастинален хематом
- Интрамурален хематом

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установяват аортна дисекация, интрамурален хематом или пенетрираща язва.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Stanford A/B] аортна дисекация; [ангажиране на клоновете]. Спешна находка; [час] — час на съобщаване.

10 «Позиция на тръба / катетър?»

Често използвано изследване: Рентгенография на гръден кош АР на легло

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Къде е върхът на всяко устройство
- Разстояние на ЕТТ до карината
- Дали NG сондата е в стомаха
- Пневмоторакс, свързан с интервенцията

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Върхът на ЕТТ е на [.. cm] над карината, върхът на NG сондата е в проекцията на стомаха, върхът на ЦВК — в проекцията на горната празна вена; няма пневмоторакс.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Върхът на NG сондата е в проекцията на десния главен бронх], не е в правилна позиция. Преди употреба: [час] — час на съобщаване.

11 «Сърдечна недостатъчност / белодробен оток?»

Често използвано изследване: Рентгенография на гръден кош; ехография на бял дроб

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Размер на сърцето (с посочване на проекцията)
- Съдов застой и интерстициален оток
- Плеврален излив
- Промяна спрямо предходното изследване

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установяват находки в полза на белодробен оток или плеврален излив.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Находки в полза на белодробен оток и двустранен малък плеврален излив; спрямо предходното изследване **[увеличение/регресия]**.

12 «Плеврален излив?»

Често използвано изследване: Рентгенография на гръден кош; ехография на гръден кош

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Има ли излив, страна
- Количество
- Съдържание (ехография: анехогенно, със септи, ехогенно)
- Подлежаща паренхимна патология
- Подходящ прозорец за интервенция (ако е поискано)

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установява плеврален излив.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Вдясно/Вляво] **[малко/умерено/голямо]** количество **[анехогенен/с усложнен вид]** плеврален излив.

ЧАСТ 3

Корем и таз

10 клинични въпроса

13 «Апендицит?»

Често използвано изследване: Дете/млад пациент/бременна: ехография; възрастен: КТ с контраст

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Визуализиран ли е апендиксът
- Диаметър, стена, околна мастна тъкан
- Апендиколит
- Перфорация, абсцес
- Ако не е визуализиран — че това не изключва апендицит

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Апендиксът е с нормален вид; не се установяват находки в полза на остър апендицит.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Находки, съответстващи на остър апендицит; перфорация или абсцес **[няма/има]**. **[Час]** — час на съобщаване.

14 «Конкремент? (бъбречна колика)»

Често използвано изследване: КТ без контраст (протокол за конкременти); ехография

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Има ли конкремент, локализация и размер (mm)
- Степен на хидронефрозата
- Контралатерален бъбрек
- Алтернативна диагноза

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установяват конкременти или хидронефроза в пикочната система.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Вдясно/Вляво] **[дистално]** в уретера **[.. mm]** конкремент и **[лек/лека/леко]** хидроуретеронефроза.

15 «Холецистит?»

Често използвано изследване: Ехография на корем

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Конкремент
- Дебелина на стената и перихолецистна течност
- Сонографски белег на Мърфи
- Диаметър на холедоха
- Усложнение (гангрена, перфорация)

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Жлъчният мехур е с нормален вид; не се установяват конкременти или белези на остър холецистит. Холедох [.. mm].

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Находки, съответстващи на остър калкулозен холецистит; холедох [.. mm]. [Час] — час на съобщаване.

16 «Обструкция / илеус?»

Често използвано изследване: Обзорна рентгенография на корем в изправено положение; КТ на корем с контраст

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Има ли обструкция, тънко/дебело черво
- Преходна зона и възможна причина
- Белези на странгулация/исхемия
- Свободен газ

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установяват находки в полза на механична чревна обструкция.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Област] — механична тънкочревна обструкция с преходна зона; белези на исхемия [няма/има].

17 «Перфорация / свободен газ?»

Често използвано изследване: Рентгенография на гръден кош в изправено положение; КТ на корем

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Има ли свободен газ
- Вероятно място на перфорацията
- Свободна течност, абсцес
- Скорошна хирургична интервенция в анамнезата

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установява свободен газ.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Пневмоперитонеум; [възможна локализация] — в полза на перфорация. [Час] — час на съобщаване.

18 «Панкреатит / усложнение?»

Често използвано изследване: КТ на корем с контраст (обикновено известно време след началото)

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Тип панкреатит (едематозен/некротизиращ)
- Перипанкреасна течност или колекция
- Съдово усложнение
- Жлъчен конкремент

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
Не се установяват находки в полза на остър панкреатит.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
Остър **[некротизиращ]** панкреатит; **[колекция/съдово усложнение]** **[няма/има]**.

19 «Травма — увреждане на паренхимен орган?»

Често използвано изследване: Травматологична КТ с контраст; FAST

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Всеки паренхимен орган поотделно
- Хемоперитонеум и количество
- Активна екстравазация
- Увреждане на червата/мезентериума
- Костни травми

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
Не се установяват находки в полза на увреждане на паренхимен орган, свободна течност или активно кървене.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
[Орган] — увреждане и хемоперитонеум; активна екстравазация **[няма/има]**. **[Час]** — час на съобщаване.

20 «Извънматочна бременност?»

Често използвано изследване: Трансвагинална и трансабдоминална ехография на таза

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Има ли вътрематочна бременност
- Аднексиална маса
- Свободна течност и нейното съдържание
- Състояние на яйчниците

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
В маточната кухина **[съдържащ жълтъчна торбичка]** се визуализира гестационен сак; не се установяват аднексиална маса или свободна течност.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
Не се визуализира вътрематочна бременност; **[вдясно/вляво]** аднексиална маса и свободна течност — находки в полза на извънматочна бременност. **[Час]** — час на съобщаване.

21 «Дивертикулит?»

Често използвано изследване: КТ на корем и таз с контраст

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Засегнат сегмент
- Усложнен ли е (абсцес, перфорация, фистула)
- Размер на абсцеса
- Алтернативна диагноза

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установяват находки в полза на дивертикулит.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[В сигмоидното] дебело черво — остър [усложнен/неусложнен] дивертикулит; абсцес [няма/има, .. mm].

22 «Болка в корема — причина?»

Често използвано изследване: КТ на корем и таз с контраст или ехография

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Има ли остра хирургична патология
- Честите причини поотделно: апендикс, жлъчен мехур, черва, пикочна система
- Свободна течност и свободен газ
- Съдова патология (аорта)

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установява остра патология, която да обясни болката в корема.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Находка]; може да обясни болката в корема. [При нужда — съобщаване].

ЧАСТ 4

Съдова патология

3 клинични въпроса

23 «ДВТ?»

Често използвано изследване: Венозна доплерова ехография на долни крайници

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Кои сегменти са оценени
- Компресивност
- Проксимална граница на тромба
- Оценени ли са вените на подбедрицата

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Вдясно/Вляво] в дълбоките вени на долния крайник [в оценените сегменти] не се установява тромбоза.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Вдясно/Вляво] [феморопоплитеалния] сегмент — остра ДВТ; проксимална граница [ниво]. [Час] — час на съобщаване.

24 «Торзия на тестиса?»

Често използвано изследване: Ехография на скротума в сива скала и цветен доплер

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Интратестикуларен кръвоток (в сравнение с другата страна)
- Размер и ехоструктура на тестиса
- Семенна връв
- Алтернативна диагноза (епидидимит)

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Двустранният тестикуларен кръвоток е симетричен; не се установяват находки в полза на торзия. Наличието на кръвоток не изключва напълно интермитентна торзия.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Вдясно/Вляво] в тестиса не се визуализира кръвоток; съответства на торзия. Спешна находка; [час] — час на съобщаване.

25 «ААА / руптура?»

Често използвано изследване: Ехография на коремна аорта; КТ ангиография

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Максимален диаметър (mm)
- Връзка с бъбречните артерии
- Периаортен хематом (руптура)
- Ограничения на ехографията при симптоматичен пациент

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Коремната аорта е с нормален калибър; не се установява аневризма.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Инфраренална ААА, максимален диаметър **[.. mm]**; белези на руптура **[няма/има]**. **[Час]** — час на съобщаване.

ЧАСТ 5

Мускулно-скелетна система и гръбначен стълб

5 клинични въпроса

26 «Фрактура?»

Често използвано изследване: Рентгенография (поне две проекции); при нужда КТ/ЯМР

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Има ли фрактура, кост и ниво
- Вътреставно разпространение
- Дислокация, ангулация
- Луксация
- При отрицателна рентгенография — възможност за окултна фрактура

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установява остра фрактура или луксация. При персистиращо клинично съмнение окултна фрактура не може да бъде изключена с рентгенография.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Вдясно/Вляво] [кост] [локализация] фрактура; [вътреставна/извънставна], [дислокация].

27 «Фрактура на бедрената шийка? (възрастен пациент, падане)»

Често използвано изследване: Таз АР + аксиална проекция на тазобедрената става; при отрицателен резултат ЯМР или КТ

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Шийка на бедрената кост и интертрохантерна област
- Дислокация
- Тазов пръстен и рамена на срамната кост
- Препоръка за допълнително изследване при окултна фрактура

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Не се установява остра фрактура в областта на тазобедрената става и таза. При високо клинично съмнение за окултна фрактура се препоръчва ЯМР или КТ.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

[Вдясно/Вляво] фрактура на шийката на бедрената кост ([с дислокация/без дислокация]).

28 «Компресия на гръбначния мозък / cauda equina?»

Често използвано изследване: ЯМР на целия гръбначен стълб или лумбален ЯМР

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Има ли компресия, ниво и причина
- Промяна в сигнала на гръбначния мозък
- Корени на cauda equina
- Допълнителни нива

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
Не се установява компресия на гръбначния мозък или на cauda equina.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
[Ниво] — [причина] като причина за компресия на гръбначния мозък. Спешна находка; [час] — час на съобщаване.

29 «Шийна травма — фрактура?»

Често използвано изследване: КТ на шиен гръбначен стълб

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Положение (подреждане)
- Белези на фрактура и нестабилност
- Краниовертебрален преход
- Превертебрални меки тъкани
- Необходимост от ЯМР за лигаментарно увреждане

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
Не се установяват остра фрактура или нарушение в подреждането на шийните прешлени.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
[Ниво] — [фрактура/луксация]; по отношение на нестабилност [час] — час на съобщаване.

30 «Септичен артрит / остеомиелит?»

Често използвано изследване: Рентгенография; ехография (излив); ЯМР

ОПИСАНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ НА

- Ставен излив
- Ангажиране на костния мозък
- Абсцес на меките тъкани
- Ограничения на образната диагностика (необходимостта от аспирация е клинично решение)

ОТРИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
[Става] — не се установява излив; не се визуализират промени в костния мозък в полза на остеомиелит.

ПОЛОЖИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
[Става] — излив и [оток на костния мозък/абсцес]; препоръчва се спешна клинична оценка за септичен артрит/остеомиелит. [Час] — час на съобщаване.

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Сега отворете Бърз бонус · Контролен списък за описанието на една страница. Отговор на клиничния въпрос, страна, размер, сравнение и съобщаване: проверете за една минута преди подписа.

За пълните шаблони на описания можете да се върнете към **Основен материал · 120 шаблона за готови описания**.